ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CONSIGLI NUTRIZIONALI IN GRAVIDANZA

MACRONUTRIENTI

- All'inizio della gravidanza è bene valutare lo stato di nutrizionale della donna ed il suo **Body Mass Index (BMI),** adeguando l'apporto energetico e nutrizionale durante la gravidanza in base al BMI pregravidico e alle Raccomandazioni OMS.
- Il peso materno prima della gravidanza e nella prima metà della gestazione è una *finestra critica* per l'intervento medico, in grado di influenzare il peso neonatale alla nascita
- In corso di gravidanza aumenta sensibilmente il fabbisogno di **proteine**, mentre è pressoché invariato quello di carboidrati e di grassi (LARN).
- I LARN riportano livelli di assunzione raccomandati di **proteine di alta qualità** per la popolazione, che corrispondono a 54 g/die per una donna adulta; questi livelli devono essere incrementati di una quota compresa tra 1 g/die nel primo trimestre di gestazione, 8 g/die nel secondo trimestre e 26 g/die nel terzo trimestre.
- Il consumo di **carboidrati semplici** non dovrebbe superare il 10-12% del fabbisogno energetico.
- Il consumo di **carboidrati complessi** dovrebbe essere tra il 45-60% del fabbisogno energetico.
- Nella scelta dei carboidrati è utile privilegiare cereali integrali per garantire anche un adeguato apporto di **fibre** (IOM).
- Il consumo di **lipidi** non dovrebbe superare il 25-30% del fabbisogno energetico, con particolare attenzione ai **grassi saturi** che dovrebbero rimanere al di sotto del 10%.
- Il fabbisogno di **DHA** aumenta di 100-200 mg al giorno durante gravidanza (EFSA, LARN).

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

MICRONUTRIENTI

Vitamina A	La supplementazione di vitamina A non è necessaria laddove l'abituale apporto giornaliero è superiore a tre volte la Recommended Daily Allowance (RDA) (ad esempio, 8000 unità internazionali o 2400 µg di retinolo equivalenti), ovvero nella maggior parte dei Paesi Sviluppati (WHO).
Acido folico	Le Linee Guida nazionali e internazionali consigliano la supplementazione giornaliera di acido folico (dai 400 µg/die ai 600 µg/die) , raccomandata per tutte le donne in gravidanza allo scopo di prevenire anemia materna, basso peso alla nascita, nascita pretermine e difetti del tubo neurale. Più specificatamente, la supplementazione di acido folico dovrebbe iniziare almeno trenta giorni prima del concepimento e continuare per il resto della gestazione, fondamentale soprattutto nei primi 3 mesi.
Vitamine del gruppo B	In gravidanza una dieta varia ed equilibrata, che soddisfi le necessità degli altri nutrienti essenziali, contiene quantità di vitamine del gruppo B sufficienti. Si raccomanda l'assunzione di 5 porzioni alla settimana di frutta e verdura, due porzioni alla settimana di legumi, assumendo occasionalmente frutta secca e di preferire i cereali integrali.
Vitamina C	In caso di un atteggiamento nutrizionale corretto da parte della gestante non è consigliata la supplementazione di vitamina C in gravidanza.
Vitamina D	La supplementazione con vitamina D in Italia non sembra essere necessaria in tutte le donne e può essere consigliata, dopo una valutazione caso per caso, solo nelle donne a rischio di ipovitaminosi per questioni ambientali o carenze alimentari.
Ferro	Concentrazioni emoglobiniche < 11 g/dl nel primo trimestre e < 10,5 g/dl oltre la 28° settimana dovrebbero essere valutate e trattate appropriatamente per ottimizzare la concentrazione emoglobinica prima del parto e ridurre il rischio di trasfusioni. Durante la gravidanza il fabbisogno giornaliero di ferro nella donna è di circa 30 mg, quasi il doppio rispetto ai 18 mg necessari a una donna non incinta. Se l'anemia in gravidanza non viene curata prontamente, le conseguenze possono coinvolgere anche il bambino, con un aumento del rischio di parto prematuro e la possibilità che il nascituro abbia un peso troppo basso. È necessario informare le donne su come migliorare l'assunzione di ferro ferroso con l'alimentazione.

Iodio	La quota stimata per evitare la carenza è di 200 µg/die (contro i 150 µg degli adulti) secondo LARN ed EFSA, 250 µg/die secondo il documento congiunto WHO/UNICEF (già United Nations International Childrens Emergency Fund).
Calcio	La supplementazione di calcio a basso dosaggio non è raccomandata nelle donne normo-calcemiche. È comunque raccomandata l'assunzione di 1200 mg di calcio durante la gravidanza e non, quantità che può essere facilmente raggiunta consumando quotidianamente alimenti ricchi in calcio. La supplementazione di calcio potrebbe essere raccomandata nelle donne a rischio per ipertensione/ pre-eclampsia, nel caso in cui la loro calcemia e/o la loro assunzione alimentare sia ridotta. In tali casi si raccomanda la supplementazione di 1,5-2,0 g/die di calcio dalla ventesima settimana fino al termine della gravidanza.
Fosforo	Al fine di garantire un adeguato sviluppo del feto sono necessari 62 mg/die di Fosforo oltre il fisiologico fabbisogno della donna, ma considerando che l'efficienza di assorbimento aumenta tanto da coprire questa differenza, non si ritiene di modificare i livelli di riferimento rispetto a quelli della donna in età fertile.
Magnesio, sodio, potassio, cloro, zinco, selenio, rame	In gravidanza, una dieta varia ed equilibrata, che soddisfi le necessità degli altri nutrienti essenziali, contiene quantità sufficienti di questi elementi, pertanto non sono necessarie supplementazioni.
Fibre	In gravidanza si consiglia, un apporto di fibre di circa 28 g/die come nelle donne in età fertile, con preferenza per il consumo di frutta, ortaggi e cereali integrali.
Acqua	Per le donne in gravidanza si raccomanda una assunzione di acqua giornaliera di 2,35L contro i 2L al giorno raccomandati per la donna in età fertile.

Rosso P. Nutrition and Metabolism in Pregnancy: Mother and Fetus. New York: Oxford University Press. 1990.
Blumfield ML, et al. Systematic review and meta-analysis of energy and macronutrient in-takes during pregnancy in developed countries. Nutr Rev. 2012; 70(6):322-36.

SINU. (Società Italiana di Nutrizione Umana). LARN-Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Revisione 2012. http://www.sinu.it/documenti/2012; 1016_LARN_bologna_sintesi_prefinale.pdf.

Rasmussen KM, Yaktine AL. Weight Gain During Preg- nancy: Reexamining the Guidelines. Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine.